



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : سحر محمود عبدالجليل خطاب

العنوان :-

الحى / المدينة : اخرى

المحافظة : الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 19-09-2026

رقم البطاقة : 28603062101247 رقم التليفون : 01227677587

العمر (تاريخ الميلاد) : 06-03-1986 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني	الوظيفة: -----	التوقيع: -----
الاسم: د/ندى حسن	الوظيفة: -----	التوقيع: -----
الاسم: د/نرمين رمضان	الوظيفة: -----	التوقيع: -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / ----- / أ.د. / ----- / د. / ----- / د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سحر محمود عبدالجليل خطاب National ID: 28603062101247	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





MDT form

3- Medical number: 83190695
Female
Old Med: 667/2024
Patient Age: 39 Y



Family history	Female history	Phone	01226646864	BMI	50	REASON OF MDT	REASON OF NOT POST OPERATIVE
HER2 (STAT)	HER2 (STAT)	NRS Score	NRS Score	GROUP	GROUP	Date of MDT	Date of MDT
Co-morbidity	Co-morbidity	Menopausal status	Menopausal status	Initial STAGE	Initial STAGE		07/12/20

Clinical data

Diagnosis Imaging : - 4.2 x 4.2 x 4.2 cm - 2.5 x 4.5 cm (with 3P LNS)			Mets Workup : CT CAP:FREE		
ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67	
8/8	8/8	3		50	
N			M		
0			0		

Sonomammography

PATIENT HISTORY
pt received 6 TC last 28/8/2024 + 4 phesgo
3/11/2024 RT SSM + SLNB:
ypTis NO
LN 0/5
free skin , resection margin

MDT OUTCOME & PLAN

In view of PCR for
adj herceptin 600 S.C x 17
-no role for PORT
-adj AI / zoladex

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY	RADIOLOGY	RADIOLOGY
SURGERY	SURGERY	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

Patient Name : حد الجليل
Patient No. : 28603C
Path No. : 585/24
Sex : Female
Age : 37 Y
Referring Doc. :

101247

Request No. : 13006517
Request Date : 12/02/2024
Verification Date : 25/02/2024
Financial Category : ملام - مبادره
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : marwa mohamed

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Right breast mass at 12 oclock
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 11/2/2024 at 11:05 a.m.

Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (V) stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultraview HRP DAB as chromogen and hematoxy counter-stain. The sections were treated against: ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (Ki67 clone (30-9).

Results:

IPT (Positive control shc appropriate reactivity):
ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8).
PR: Strong nuclear reaction in 90% tumor cells (Allred score 8/8).
Her2: Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+).
Ki67: 50% nuclear reaction in tumor.

Conclusion:

Right breast cancer, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade III, with focal DCIS.

IPT:

ER: Positive (score 8/8).
PR: Positive (score 8/8).
Her2: Positive (score 3+).
Ki67: Positive in 50% of tumor cells.

Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining in staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%

Verified by :

Dr. Heba Hasan

Printing Date : 28/02/2024 10:40:30

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed

CAP

غرفة رقم (4) - الدور الاول - مبنى رقم 987 - نيتة Corniche - Abier El Qadema - Cairo, Egypt
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - Abier El Qadema - Cairo, Egypt



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name الأستاذ / سحر محمود عبد الجليل
Patient No. 28603062101247
Path No. 585/24
Sex Female
Age 37 Y
Referring Doc.

Request No. 13006
Request Date 12/02/
Verification Date 25/02/
Financial Category - مبادئ
Department Out Pa
Registered by marwa

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
* Scoring system: "Her-2"
Reference: ASCO-CAP Her-2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within the invasive tumor cells. IHC 1: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Amal Hareedy
Dr. Heba Hassan

Verified by :
Dr. Heba Hasan

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
ورام دار السلام
شعبة الأشعة

Total DLP (mGy.cm): 1392

Patient Name: Sahar Mahmoud Abd Al Galeel	Date : 28/02/2024
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 38 Year(s)
Medical ID: 667/2024	47319

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Right breast upper central solid mass lesion measuring about 3.5 x 2.2 cm.
- Few small prominent right axillary lymph nodes largest measuring 1 x 0.5 cm.
- Few left upper lobe calcified pulmonary nodules likely old granuloma.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department



مركز
تخصصية
السلام

Total DLP (mGy.cm): 1392

Patient Name: Sahar Mahmoud Abd Al Galeel	Date : 28/02/2024
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 38 Year(s)
Medical ID: 667/2024	47319

- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defect or diverticular outpouching.
- IUCD is seen.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Left iliac bone island.
- No suspicious osseous lesions.

Opinion:

- Right breast lesion with ipsilateral small prominent axillary lymph nodes.
- No evidence of pulmonary, hepatic or osseous metastasis on non contrast basis.

Dr. Ali Saber, MSc.

Dr. Amr Farouk, M.D.

Echo report

NAME:

7/3/ 2025

Age:

77 V
C2

EF	76 %	54-74%	PWT		0.6-1.1cm
LV EDD	42	3.5-5.7cm	AO		2.0-3.7cm
LVESD	23	2.2-4.0cm	LA	33	1.9-4.0cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm (supine)
SVT	2.9	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

dimensions:

Wall thickness:

Diastolic function:

IMA

size

Mid-root dimension

Aortic Valve

Mitral valve

Tricuspid valve

Pulmonary valve

Right side size and systolic function

Cardiac masses and thrombi

Pericardium

Pericardial diameter and collapsibility.

Conclusion:

Normal RR. MV prolapse
max P 6=6.7 cm

RR 20 mmHg
normal TR
C2